

【讲稿全文】

PPT Page 1 【引入：另一种维度的差异】 刚才我们讨论了不同人群的差异，现在，让我们把目光转向另一个维度：也就是发达地区与欠发达地区之间的差异。

PPT Page 2 【核心矛盾：城乡之别】 这种区域差异，最直观地体现在城市与农村之间，以及一线发达城市与相对落后的城市之间。 虽然我们有理由相信，随着城市群的“富集效应”和经济发展，城市与城市之间的差距在未来是会慢慢缩小的。但是，**城乡之间的差异**不仅基数大，而且存在着某种“结构性崩盘”的风险。所以，我们今天的分析，将重点聚焦在这一块最硬的骨头——城乡差异上。

PPT Page 3 【直观数据：巨大的投入产出差】 要看清分配制度的问题，最直接的办法就是看“钱”。我们来看这两组对比数据。 大家请看，城镇职工医保的人均支出，是城乡居民医保的 **4 倍以上**。这意味着什么？意味着城镇职工享受着更充沛的资金池、更优质的医疗资源和更高的报销比例；而农村居民医保，目前大多只能维持最基本的医疗服务。

这里我要稍微解释一下，为什么我们用“城镇职工”和“城乡居民”这两个指标来对比城乡？因为中国的产业结构决定了，城镇就业人口多为企事业单位员工，天然覆盖在职工医保下；而农村人口大多维持着自然经济或灵活就业，主要依靠居民医保。所以，这两个指标的差距，本质上就是中国城乡二元结构的映射。

再看具体的例子，像北京、上海这样的一线城市，其医保的“含金量”与西部农村地区相比，确实存在着巨大的鸿沟。

PPT Page 4 【深层透视：制度性的错位】 看完了数据，我们再来挖掘一下数据背后的制度性不平衡。 首先，大家注意这个现象：近几年居民医保的参保人数在下降。虽然官方解释说是结构变化，但我们不能忽视一个事实：**确实有一部分农村居民，因为缴费标准逐年提高，觉得“交不起了”或者“不划算”而选择了断缴。** 这说明，在医保制度转型的过程中，农村人口承受的压力是远大于城镇人口的。

其次，是**需求与保障的错位**。职工医保覆盖的人群（城镇就业和退休人员）医疗需求旺盛，资金也充裕；而居民医保覆盖的农村和非就业人群，理论上更需要基础医疗和预防。但在实际运行中，一旦农村参保者得了大病，有限的县乡医疗条件根本治不了，他们被迫涌向城市大医院，这不仅加剧了个人经济负担，也挤占了城市的医疗资源。

最后，是**筹资机制的脆弱性**。职工医保是“强制缴纳、单位对半”，资金池很稳；而居民医保高度依赖“个人缴费+政府补贴”。这就像是看天吃饭，地方财政好，补贴就多；地方财政一旦吃紧，医保基金就也跟着紧张。这种筹资模式，天然决定了它目前只能“保基本”，很难有提质的空间。

PPT Page 5 【现实痛点：不只是钱的问题】 我们继续深究，这不仅仅是钱多少的问

题，更是“命”的问题。这种差异体现在三个方面：第一，**保障能力的天壤之别**。上海居民可能已经在报销最新的靶向药了，而甘肃的农民可能面临着“医保目录里根本没有我要用的药”的困境。第二，**医疗资源的可及性**。优质的三甲医院都在城里，农村有钱也难买到好服务。第三，**风险的放大效应**。低保障群体因为怕花钱，往往小病拖成大病，最后反而花得更多，甚至陷入长久的债务危机。这显然违背了我们建立医保制度的初衷。

PPT Page 6 【原因归纳：三座大山】 总结一下，造成这种城乡巨大差异的原因，主要有三点：

1. **经济基础差异**：发达地区税收多，财政补贴能力强，这是硬实力的差距。
2. **历史资源积累**：好的医院、好的医学院，历史上就集中在发展较早的工业化城市，这是一种路径依赖。
3. **人口结构流动**：现在的局面是，年轻力壮的劳动力都去了发达地区，留守在欠发达地区的多是老弱病残，这进一步加剧了基金的失衡。

PPT Page 7 【政策现状：调节与局限】 面对这些问题，政府当然没有坐视不管。我们看到了**转移支付**，2023年中央下拨了约340亿元补助资金，重点就在向中西部倾斜；我们看到了**建设区域医疗中心**，国家正努力把好的医疗资源“搬”到河南、云南、新疆等地。

但是，我们要清醒地认识到：目前的措施多是一次性的“输血”。它很难从根本上改变资源配置的结构。甚至面临一个尴尬的挑战：我们把设备建好了，但因为本地医保基金池子太小，付不起高端医疗费用的费用，同时也留不住好医生，最后资源可能又回流到了发达城市。

PPT Page 8 【机制总结：正负循环的死结】 接下来说一下对目前这种现状的总结和思考。我们刚才看了一堆数据和案例，其实可以总结出一个非常典型的“循环机制”。大家看这张图的逻辑：

- 在发达地区，这是一个“正向循环”：高工资带来了高缴费基数，医保基金结余就充足，进而有能力提高报销待遇。待遇好了，更能吸引人才流入，人才又进一步扩大了缴费基数。
- 而在欠发达地区，却容易陷入“负向循环”：人口（特别是年轻劳动力）流出，导致缴费人群减少，基金压力大，被迫限制待遇水平，这反过来又加速了人才流失。

PPT Page 9 【未来的方向】 面对这个死结，我们未来的改革方向在哪？

- **短期来看**，我们需要建立动态的中央调剂机制，不能只看人头，要综合考虑人口结构和疾病负担。同时，推进跨省就医费用的协同结算，让流出地和流入地

按比例分担，谁受益谁担责。

- **长期来看**，核心还是要打破壁垒。比如探索让灵活就业者能更顺畅地接入职工医保，利用现在热门的数字化、远程医疗技术去抹平一部分地理空间上的医疗鸿沟。

PPT Page 10 【转场：视角的跃升】 讲完了地区差异，我们把视角再拉高一点。我们来探讨一个更本质、更尖锐的问题：**我们的医疗保险制度，到底是在帮穷人，还是在帮富人？** 也就是我们接下来要讨论的第四部分：医疗保险制度是“益富”还是“亲贫”？

PPT Page 11 【核心结论：亲贫与益富的博弈】 先直接抛出我们的核心结论，大家可以看这个对比：

- **社会医保（也就是我们要保的基本盘）整体是“亲贫”的。** 它通过报销机制，显著降低了低收入群体的负担。数据显示，社会医保起到了抑制收入差距扩大的再分配作用，这对于防止“因病致贫”至关重要。
- **而商业医保，呈现出明显的“益富”效应。** 为什么？因为商业保险是市场行为，是以盈利为导向的。门槛高、保费高，高收入群体买了之后获得更多报销，这反而可能加剧收入不平等。

大家看这组西南财经大学的调查数据对比：在基尼系数上，实施社会医保后，系数是下降的（从 0.597 降到 0.568），说明不平等在缩小。但如果只看商业医保，系数反而是上升的。最讽刺的是这一行数据：商业医保对高收入群体的家庭收入边际影响是正的，也就是越富的人，通过商业保险获得的资产保全效果越好。

PPT Page 12 【机制分析：雪中送炭 vs 锦上添花】 我们把刚才的结论展开，看看具体的机制图和洛伦兹曲线。大家看左边的图：

- **社会医保的机制是“雪中送炭”。** 低收入群体从社会医保中获得的直接报销比例，以及它所带来的间接收入补偿，是远高于高收入群体的。它最大的作用是缓解“债务陷阱”，防止低收入家庭因为一次大病就彻底返贫。
- **商业医保的机制是“锦上添花”。** 高收入群体有能力购买，通过保险优化了风险配置，放大了财富效应。

图中的曲线也直观地反映了这一点：未实施社会医疗保险的曲线在实施后的右下方，说明社会医保拉平了贫富差距；而商业医保的曲线则显示它扩大了不平等。

PPT Page 13 【隐蔽的不公：农村筹资的痛点】 但是，我们能不能说社会医保就绝对公平了呢？并不是。这里有一个非常隐蔽但严峻的问题，出现在**农村地区**。这就是我们说的“筹资公平性”问题。现在的城乡居民医保（也就是咱们说的老家交的那个医保），采用的是“定额缴费”。比如 2023 年，人均筹资标准是 1020 元，个人要缴 380 元。大家可能觉得 380 元不多，对城里人可能就是一顿聚餐的钱。但数据告诉我们，

这 380 元对农村低收入群体来说，占到了他们年收入的 **6.97%**；而对高收入群体，这只占 **0.76%**。

这在经济学上叫“累退性”。结果就是：**穷人的缴费负担反而比富人重**。这就违背了“按能力付费”的纵向公平原则。而且，农村低收入人群往往健康状况更差，但受限于医疗条件，他们的报销贡献率反而低于高收入组。这也就是为什么我们在最开始提到的，农村参保人数在下降的一个深层经济原因——对于穷人来说，这张“保命网”太贵了。

PPT Page 14 【政策启示：改革三步走】 最后，基于以上所有的分析，我们对未来的医保改革提出几点具体的政策建议：

第一，**改革筹资机制（这是最紧迫的）**：建议将居民医保的“定额缴费”改为“按收入比例缴费”。比如参考职工医保，设定一个低费率（如 2%），这样能真正实现高收入者多缴、低收入者少缴。当然，这需要税务信息的全面打通。

第二，**强化社会医保的主体地位**：既然商业医保是“益富”的，那政府就更要兜住底。要持续加大财政投入，减少低收入群体对商业保险的被动依赖，不能让穷人因为买不起商保而失去救治机会。

第三，**动态调整医保目录与制度整合**：钱要花在刀刃上，目录优化要重点保障大病支出，核心目标是防止“因病致贫”的反弹。而最终的目标，还是要把城乡居民医保和职工医保逐步统一，建立全民统一的医保体系，从根源上消除因为身份不同、制度碎片化带来的不公平。